

Datos Personales							
Nombre:	JULIO CESAR LAYTON ROJAS	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	1972-12-16	Edad	53 Años, 2 Meses, Y 2 Días
Identificación:	CC - 79683748	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	EMPLEADO
Correo Electrónico:	Laytoncolombia@gmail.Com.Co - 79683748			Dirección:	Carrera 7 # 14 - 60		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	EPS010 - (EPS SURA)						

Apertura psicología del 2026-02-17 17:44:51: 53 años, 2 meses, y 2 días

DATOS GENERALES

Remisión
AUTORREFERIDO - SURA Medicina Prepagada

DX principal
NREF - NO REFIERE
DX Relacionado 1
NREF - NO REFIERE
DX Relacionado 2
NREF - NO REFIERE

Código de consulta
890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta
“Me han atendido varias veces en la aseguradora de positiva en psicología por depresión, sentimientos de impotencia, de rabia” “Mi niña Isabel nació cuando Mi mamita se fue al cielo”.

Enfermedad Actual

Paciente adulto masculino que consulta por dificultades significativas en el vínculo paterno-filial con su hija de 4 años, en el contexto de conflictos persistentes con la madre de la menor y su familia extensa. Refiere que la relación de pareja inició de manera temprana y que, a los seis meses, decidieron realizar un proceso de fertilización in vitro debido a antecedentes de embarazo de alto riesgo. Durante el embarazo, el paciente señala distanciamiento progresivo por parte de la madre de la niña, quien priorizaba el acompañamiento de su familia de origen, especialmente una hermana con alta influencia en la toma de decisiones. Posterior al nacimiento, intentaron convivencia breve (aproximadamente tres semanas); sin embargo, refiere incremento de conflictos de pareja, incluyendo episodios de agresión verbal y física por parte de la madre, lo que derivó en la separación. Desde entonces, la madre y la menor residen con la familia materna. El paciente manifiesta que, tras la separación, el contacto con la hija ha sido limitado y mediado por la familia materna, señalando restricciones para compartir espacios a solas con la menor. Indica que durante el primer año de vida existieron permisos intermitentes de contacto, los cuales posteriormente se redujeron tras desacuerdos entre los progenitores. Actualmente, refiere que las visitas se realizan en presencia de terceros y que percibe dificultades en el establecimiento de un vínculo cercano con la niña. Describe conductas de rechazo por parte de la menor en contextos donde se encuentra la familia materna (negativa a interactuar, evitación física, expresiones de desagrado), contrastando con momentos aislados en los que, al estar a solas, la niña se muestra afectuosa y receptiva. El paciente expresa preocupación por la calidad del vínculo paterno-filial, señalando percepciones de posible interferencia relacional por parte del entorno materno. Asimismo, refiere que la menor presenta comportamientos de timidez, temor ante figuras nuevas y resistencia al contacto físico con familiares paternos. Durante la consulta, aporta material audiovisual donde se observa interacción padre-hija caracterizada por evitación conductual de la menor, con signos de incomodidad e inhibición en presencia del adulto. Niega ejercicio actual de autoridad parental efectiva y refiere que la última interacción percibida como positiva ocurrió aproximadamente hace cuatro meses. Como antecedente relevante, menciona fallecimiento de su madre hace cinco años, previo al nacimiento de la hija.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico
Bloqueo En El Coxis

Traumáticos
Accidente De Transito

Paraclínicos
Rx, Ecografías, Radiografía De Pulmones.

Patología
No Refiere

Tóxicos

Medicación
No Refiere

Hospitalizaciones
Si, Por Bronquitis (hospitalización Hace 1 Año Y Medio).

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Diabetes, Hipertensión, Cáncer De Páncreas Madre, Tiroides	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa El paciente cuenta con formación profesional en comunicación social y periodismo, así como estudios en publicidad, refiriendo haber cursado dos carreras profesionales con duración aproximada de cinco años cada una. Durante su etapa escolar, reporta haber sido víctima de acoso escolar asociado a una alteración estética dental (trauma en incisivos anteriores), lo cual generó inseguridad significativa en su autoimagen y dificultades en la interacción social hasta aproximadamente los 17 años. Señala que posteriormente recibió intervención odontológica correctiva, lo que favoreció mejoría en su autoconcepto y progresiva integración en contextos sociales. Refiere que, a partir de dicha intervención, logró desarrollar mayor apertura interpersonal y adaptación social, consolidando posteriormente su desempeño académico y profesional.
Historia laboral El paciente refiere trayectoria laboral en el sector público, destacando participación en diferentes cargos obtenidos mediante procesos meritocráticos. Señala experiencia previa como periodista en el Diario Magdalena y vinculación laboral en entidades públicas como la Corporación Autónoma Regional (CAR). Actualmente se encuentra vinculado laboralmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desempeñando funciones en el cargo de gestor III. Manifiesta percepción subjetiva de subestimación profesional en relación con el rol asignado, considerando que sus competencias podrían estar infrautilizadas. En cuanto al área interpersonal, refiere adecuado funcionamiento en el entorno laboral, con relaciones interpersonales estables y sin conflictos significativos en el contexto ocupacional.
Historia familiar Actualmente el paciente reside solo en la ciudad de Santa Marta, en el contexto de un ascenso laboral en la DIAN. Refiere dinámica de desplazamiento semanal entre Santa Marta y Valledupar, permaneciendo en Valledupar durante la semana laboral y regresando los fines de semana a Santa Marta con el objetivo principal de facilitar el contacto con su hija. Manifiesta que su red familiar actual es limitada y que las relaciones con la madre de la menor y su familia extensa son conflictivas y distantes, lo cual ha impactado negativamente la dinámica coparental y el acceso al vínculo paterno-filial. Refiere ausencia de convivencia familiar estable en la actualidad, manteniendo un estilo de vida predominantemente individual.
Historia social El paciente refiere haber mantenido redes sociales estables a lo largo de su trayectoria vital, caracterizadas por vínculos de amistad duraderos. Describe un estilo relacional selectivo, con tendencia a establecer relaciones interpersonales cercanas dentro de círculos sociales reducidos, priorizando la confianza y la afinidad emocional. No reporta dificultades significativas en la interacción social general, ni antecedentes de aislamiento social marcado en la vida adulta.
Historia emocional/afectiva El paciente refiere antecedentes de vulnerabilidad emocional durante la niñez, asociados a experiencias de inseguridad personal que favorecieron conductas de retraimiento social y sentimientos de inferioridad. Señala que durante la adolescencia logró superar dichas dificultades, alcanzando mayor estabilidad emocional y funcional, lo que le permitió consolidar su desempeño académico, laboral y relacional en etapas posteriores. Como eventos vitales significativos, refiere el fallecimiento de su madre hace aproximadamente cinco años y, posteriormente, el nacimiento de su hija, situaciones que identifica como altamente impactantes a nivel emocional. Posterior a estos acontecimientos, describe la aparición de sintomatología afectiva caracterizada por insomnio, tristeza persistente, ansiedad y malestar emocional. En la actualidad, manifiesta sentimientos de impotencia, tristeza e irritabilidad, principalmente asociados a la percepción de dificultades en el ejercicio de su rol paterno y la limitada relación con su hija.
Historia deportiva El paciente refiere que actualmente no participa en actividades deportivas ni rutinas de ejercicio estructuradas. No reporta práctica deportiva regular en el momento de la evaluación.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial Se realiza entrevista semiestructurada orientada a explorar el funcionamiento global del paciente, identificando áreas conservadas y afectadas en relación con la problemática actual. La evaluación se enfocó en la identificación de red de apoyo, factores estresores, detonantes emocionales y sintomatología asociada a ansiedad y estado de ánimo. Durante la entrevista se identifican elementos relacionados con dificultades en la autoafirmación en el rol paterno, evidenciándose vacilación al momento de referirse a la toma de decisiones frente a su hija. El paciente expresa temor anticipatorio ante posibles reacciones de la expareja, lo cual parece influir en la limitación del ejercicio autónomo de su rol parental. Esta dinámica se asocia a antecedentes de interacciones conflictivas previas, configurando un patrón de evitación conductual en situaciones vinculadas a la autoridad parental. Se complementa con observación clínica directa durante la entrevista. A nivel conductual, se identifican indicadores compatibles con activación ansiosa, incluyendo discurso con tendencia a la tangencialidad, dificultad para mantener un hilo narrativo lineal y ampliación de contenidos sin cierre temático claro. En varios momentos el paciente pierde la idea principal, logrando posteriormente retomarla con esfuerzo. A nivel afectivo, se observa tono emocional ansioso, con preocupación marcada frente a la situación vincular con su hija. No se evidencian signos de angustia desbordada ni alteraciones del curso del pensamiento de tipo psicótico. El paciente se muestra consciente de su malestar emocional. Refiere percepción de red de apoyo limitada en la actualidad y exposición a estresores crónicos relacionados con el conflicto coparental y las dificultades en el ejercicio del rol paterno, los cuales actúan como mantenedores del malestar emocional.
--

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica NO REFIERE
Intervención neurológica NO REFIERE
Intervención neuropsicológica NO REFIERE
Otras intervenciones El paciente cuenta con antecedente de atención psicológica en el año 2025, según revisión de historia clínica aportada durante la consulta actual. En dicha valoración se documenta manejo en modalidad de consulta y control por psicología, con impresión diagnóstica bajo codificación Z65.9 – Problemas relacionados con circunstancias psicosociales no especificadas . La

intervención previa estuvo orientada al abordaje de factores psicosociales asociados a malestar emocional, sin registro de trastorno mental estructurado en ese momento.
Se deja constancia de que el paciente aporta soporte documental de dicha atención.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

El paciente ingresa a consulta con adecuado saludo y actitud colaboradora. Presenta apariencia acorde al contexto sociocultural y edad cronológica, con adecuada presentación personal. Llama la atención decoración ungueal con símbolos patrios (bandera de Colombia en alusión a su hija y bandera de Venezuela en referencia a un menor que refiere haber acogido), lo cual se interpreta dentro de un contexto simbólico afectivo. Se encuentra consciente, alerta y orientado en las tres esferas (auto y alopsíquicamente). Atención conservada durante la entrevista. Lenguaje de curso taquilálico, con tendencia a verborrea y asociaciones tangenciales, aunque logra retomar el hilo narrativo con esfuerzo. Pensamiento de curso lógico, sin evidencia de ideas delirantes. A nivel afectivo se observa eutimia basal con reactividad emocional acorde al contenido narrado, evidenciándose malestar psicológico asociado a la situación vital actual. Niega ideación suicida activa o pasiva. No se evidencian alteraciones sensorio perceptivas (alucinaciones o ilusiones). Funciones cognitivas globalmente conservadas; inteligencia impresiona dentro de rango promedio. Juicio de realidad conservado. Se identifica conciencia de enfermedad parcial, con reconocimiento del sufrimiento psicológico actual y su relación con las dificultades vinculares en el ejercicio del rol paterno.

Ciclos del Sueño

El paciente refiere alteración en los ciclos de sueño, caracterizada por patrón intermitente y dificultades en la continuidad del descanso nocturno. Señala uso actual de suplementos de venta libre, incluyendo melatonina y preparados naturales tipo “Psicorelax”, sin prescripción médica formal.
Niega, al momento, uso de hipnóticos formulados o manejo farmacológico especializado para el insomnio.

Apetito

CONSERVADO

Actividades de Autocuidado

INDEPENDIENTE

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F432 - TRASTORNOS DE ADAPTACION
Impresión Diagnóstica Relacionada 1
F43.22 - TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON ANSIEDAD
Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

NO REFIERE

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer la regulación emocional y el afrontamiento adaptativo del paciente frente a estresores psicosociales actuales, fortaleciendo recursos personales, rol parental y bienestar psicológico global.

Objetivos Específicos

- Brindar psicoeducación sobre ansiedad, duelo y respuestas adaptativas al estrés crónico.
- Fortalecer habilidades de regulación emocional y manejo de activación ansiosa.
- Abordar procesos de duelo no resueltos asociados a pérdidas significativas.
- Favorecer reestructuración cognitiva frente a pensamientos de impotencia y descontrol.
- Desarrollar estrategias de afrontamiento funcional frente al conflicto coparental.
- Fortalecer la autoeficacia percibida en el ejercicio del rol paterno.
- Implementar higiene del sueño y estrategias conductuales para mejorar la calidad del descanso.
- Promover ampliación de red de apoyo y recursos protectores.

Sugerencias e Interconsultas

- Se sugiere valoración por Psiquiatría, con el fin de valorar necesidad de apoyo farmacológico complementario.

Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES

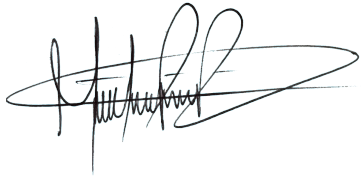
El paciente presenta adecuado insight y disposición al proceso terapéutico, lo cual constituye un factor pronóstico favorable. Se evidencia funcionamiento cognitivo conservado, estabilidad laboral y capacidad reflexiva, elementos que facilitan la intervención psicoterapéutica.

Se identifican estresores relacionales persistentes que podrían actuar como mantenedores del malestar si no se abordan desde un enfoque psicoterapéutico estructurado.

RECOMENDACIONES

- Continuar proceso psicoterapéutico individual con enfoque en regulación emocional y afrontamiento adaptativo.
- Implementar rutinas estructuradas de higiene del sueño, reduciendo automedicación con suplementos sin supervisión profesional.
- Favorecer espacios de autocuidado y regulación fisiológica (actividad física, respiración, pausas activas).

- Evaluar, de ser necesario, acompañamiento interdisciplinario (psiquiatría) si se incrementa la alteración del sueño o la sintomatología ansiosa.
- Considerar orientación psicojurídica o terapia de enfoque coparental en caso de persistir dificultades en la dinámica vincular con la hija.
- Fortalecer red de apoyo social significativa.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER

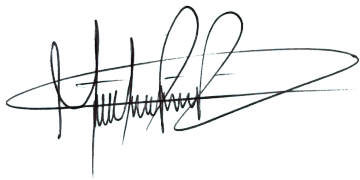
Datos Personales							
Nombre:	JULIO CESAR LAYTON ROJAS	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	1972-12-16	Edad	53 Años, 2 Meses, Y 2 Días
Identificación:	CC - 79683748	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	EMPLEADO
Correo Electrónico:	Laytoncolombia@gmail.Com.Co - 79683748			Dirección:	Carrera 7 # 14 - 60		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	EPS010 - (EPS SURA)						

Impresión Diagnóstica:
F432 - TRASTORNOS DE ADAPTACION

Impresión Diagnóstica Relacionada 1
F43.22 - TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON ANSIEDAD

Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

ÓRDENES MÉDICAS		
No.	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
1	890284 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Con El Fin De Valorar Necesidad De Apoyo Farmacológico Complementario.	1



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU

